



麻疹

2026年7月15日 | 阅读时间 10 分钟 (2623 字)

[English](#)

[العربية](#)

[Français](#)

[Русский](#)

[Español](#)

重要事实

- 麻疹是一种由病毒引起的传染性极强的严重空气传播疾病，可引起严重并发症和死亡。
- 在2000-2024年期间，麻疹免疫接种防止了近5900万人死亡。
- 尽管已有安全且具有成本效益的麻疹疫苗，但在2024年，全球估计仍有9.5万人死于麻疹，其中大多数为5岁以下未接种疫苗或接种不足的儿童。
- 2025年，接种首剂麻疹疫苗的儿童比例为84%，略低于2019年的86%。

概述

麻疹是一种由病毒引起的传染性极强的疾病。在感染者呼吸、咳嗽或打喷嚏时，很容易传播。它可能引起严重的疾病、并发症，甚至死亡。

任何人都有可能感染麻疹，但最常见于儿童。

麻疹会感染呼吸道，然后扩散到全身。症状包括高烧、咳嗽、流鼻涕和全身皮疹。

接种疫苗是预防感染麻疹或将其传播给他人的最好方法。疫苗是安全的，可以帮助你的身体抵抗病毒。

在1963年推出和广泛接种麻疹疫苗之前，重大麻疹流行疫情大约每两三年发生一次，估计每年造成260万人死亡。

尽管已有安全且具有成本效益的疫苗，但据估计，2024年有9.5万人死于麻疹，大部分是五岁以下儿童。

在2000和2024年期间，各国、世卫组织、麻疹和风疹伙伴关系以及其他国际伙伴开展的加速免疫活动成功防止了约5900万人死亡。据估计，疫苗接种使麻疹死亡人数从2000年的78万人下降到2024年的9.5万人(1)。

体征与症状

麻疹症状通常在接触病毒之后7-14天内开始出现。最明显的症状是出现明显的皮疹。

早期症状通常持续4-7天。其中包括：

- 发热
- 流鼻涕
- 咳嗽
- 红眼和流眼泪
- 脸颊内侧出现小白点。

皮疹在最初症状出现后3-5天开始出现，通常见于患者面部和上颈部。皮疹在大约3天内扩散，最终扩散到躯干、手臂、腿和脚。皮疹通常持续4-8天才会消退。

大多数麻疹死亡是由与这种疾病相关的并发症引起。

并发症包括：

- 失明
- 脑炎（一种引起大脑肿胀和潜在脑损伤的感染）
- 严重腹泻和相关脱水
- 耳部感染
- 包括肺炎在内的严重呼吸问题。

如果妇女在妊娠期内感染麻疹，这对母亲来说可能是危险的，并且可能导致孕妇流产或婴儿早产且出生体重不足。

并发症最常见于5岁以下儿童和30岁以上的成人。营养不良的儿童更容易患上这种疾病，尤其是那些缺乏足够维生素A或因艾滋病毒或其他疾病而导致免疫系统功能减弱的儿童。麻疹本身也会削弱免疫系统，并且会让身体“忘记”如何保护自己免受感染，使儿童极易受到感染。

哪些人面临风险？

所有没有免疫的人（没有接种疫苗或接种过疫苗但没有产生免疫力）都有可能感染。未接种疫苗的幼儿和孕妇出现严重麻疹并发症的风险最高。

麻疹仍然很常见，尤其是在非洲、中东和亚洲部分地区。绝大多数麻疹死亡发生在人均收入低或卫生基础设施薄弱且很难为所有儿童提供免疫接种的国家。

在经历自然灾害或冲突或正从自然灾害或冲突中恢复的国家，卫生基础设施和卫生服务遭到破坏，常规免疫接种中断，居住营地过度拥挤增加了感染风险。营养不良或因免疫系统薄弱引起的其他原因致使儿童面临麻疹的死亡风险最高。

传播

麻疹是世界上传染性最强的疾病之一，通过接触受到感染的鼻腔或咽喉分泌物（咳嗽或打喷嚏）或呼吸麻疹患者呼出的空气而传播。麻疹病毒在空气中或受感染物体表面2小时内可保持活性和传染性。由于这一原因，它的传染性很强。每位麻疹感染者可导致多达18例继发感染。

感染者在出疹前后4天内具有传染性。

麻疹疫情会导致严重的并发症和死亡，特别是在营养不良的幼儿中。在接近消除麻疹的国家，来自其他国家的输入性病例仍是重要传染源。

治疗

麻疹没有特效治疗方法。护理应侧重于缓解症状，使患者感到舒适，并预防并发症。

多喝水和进行脱水治疗可以补充因腹泻或呕吐造成的液体流失。健康饮食也很重要。

医生可使用抗生素来治疗肺炎和眼耳感染。

对于所有疑似麻疹的5岁以下儿童，建议服用两剂维生素A，在确诊后立即服用首剂，并于次日服用第二剂，具体剂量请遵医嘱。若出现任何伴有眼部并发症的维生素A缺乏临床体征，建议在4-6周后服用第三剂。这样可使即使在营养良好的儿童中也可能出现的维生素A水平偏低情况恢复到正常。补充维生素A有助于预防麻疹的其他并发症，包括眼损伤和失明。此外，补充维生素A还有助于降低麻疹死亡率。

预防

全社区接种疫苗是预防麻疹的最有效方法。所有儿童都应接种麻疹疫苗。麻疹疫苗安全有效，而且廉价。

儿童应接种两剂疫苗以确保获得免疫力。在麻疹常见的国家，第一剂疫苗通常在婴儿9个月大时接种，在其他国家则在12-15个月大时接种。第二剂应在幼儿晚期接种，通常在15-18个月。

麻疹疫苗一般单独接种或经常与腮腺炎、风疹和/或水痘疫苗一起接种。

在发病率高的国家，常规麻疹疫苗接种与大规模免疫接种运动结合起来对于降低全球麻疹死亡率至关重要。麻疹疫苗已经使用了大约60年，每个儿童的疫苗成本不到1美元。麻疹疫苗也用于突发事件，以阻止疫情蔓延。难民中暴发麻疹疫情的风险特别高，应尽快为难民接种疫苗。

将不同疫苗结合起来使用会略微增加成本，但可以分担交付和接种成本，更重要的是，增加了预防风疹的好处，风疹可以感染子宫内的婴儿，是最常见的疫苗可以预防的感染。

2025年，77%的儿童接种了两剂麻疹疫苗，全世界约84%的儿童在一周岁前接种了一剂麻疹疫苗。建议接种两剂疫苗，以确保获得免疫力并防止疫情暴发，因为并非所有儿童都能在接种第一剂疫苗后产生免疫力。

据世卫组织和联合国儿童基金会估计，2025年大约有2900万婴儿未获得麻疹适当防护。

世卫组织的应对

2020年，世卫组织和全球利益攸关方批准了《2021-2030年免疫议程》。该议程是要将麻疹作为卫生系统是否具有为儿童提供基本疫苗接种能力的一项指标，以实现作为一项影响核心指标的区域目标。

世卫组织在2020年发布了[麻疹和风疹战略框架](#)，确定了实现和保持区域消除麻疹和风疹目标有必要实施的七个战略重点。

如果不持续关注，得之不易的成果很容易会失去。在儿童未接种疫苗的地方，就会暴发疫情。[世卫组织免疫战略咨询专家组](#)根据目前麻疹疫苗接种覆盖率和发病率趋势得出结论认为，由于这种疾病在很多实现或接近实现消除目标的国家死灰复燃，消除麻疹工作面临威胁。

世卫组织继续加强[全球麻疹和风疹实验室网络](#)，以确保麻疹的及时诊断和跟踪这种病毒的传播情况，以协助各国协调有针对性的疫苗接种活动，减少因这种疫苗可预防疾病引起的死亡。

2030年免疫议程麻疹和风疹伙伴关系

[2030年免疫议程麻疹和风疹伙伴关系](#)是由美国红十字会、联合国基金会、美国疾病预防控制中心（疾控中心）、全球疫苗免疫联盟、盖茨基金会、联合国儿童基金会和世卫组织牵头组成的一个伙伴关系，旨在实现《2030年免疫议程》中的麻疹和风疹具体目标。该伙伴关系系于2001年启动，原名为“麻疹和风疹倡议”，重振后的伙伴关系致力于确保没有儿童死于麻疹或在出生时患有先天性风疹综合征。该伙伴关系正在帮助各国制定计划、资助和衡量持续遏制麻疹和风疹方面的工作。

参考文献

1. [2000-2024年全球麻疹消除进展，《疫情周报》，第48期，2025年，100，591-604页](#)